Arthrose

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — III

À RETENIR

- Pathologie dégénérative = **indication rare** de la SO.
- Hyperfixation très modérée, pouvant devenir très marquée lors des poussées inflammatoires.
- Ostéophytes : fixation très intense lors de leur constitution, puis **isofixants** à long terme.
- Rachis : cervical +++ (uncarthrose, hyperfixations latéralisées), charnière lombo-sacrée +++.
- TEMP : arthrose interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ; **atteinte du pédicule ⇒ image suspecte de lésion osseuse secondaire**.
- Gonarthrose : atteinte simultanée du condyle + plateau tibial ⇒ arthrose.

1. Généralités

- Arthrose : pathologie **dégénérative** = indication rare.
- Hyperfixation très modérée, mais qui, à l'occasion de poussées inflammatoires, peut devenir très marquée.
- Les ostéophytes peuvent fixer le radiotraceur de façon très intense lors de leur constitution ; à plus long terme, ils deviennent isofixants.

2. Arthrose rachidienne

- **Rachis cervical +++** : hyperfixations latéralisées (uncarthrose).
- **Rachis dorsal** : aspect hétérogène de la fixation + hyperfixation modérée des jonctions costo-vertébrales.
- **Rachis lombaire** : charnière lombo-sacrée +++, souvent remaniée par des lésions arthrosiques ; l'hyperfixation peut être assez intense.
- Diagnostic différentiel : confrontation radiographique → TEMP/TDM.
- **TEMP** : localisation précise de l'hyperfixation sur la vertèbre :
  - arthrose interapophysaire postérieure (Baastrup) **[à vérifier]** *à vérifier : la maladie de Baastrup désigne classiquement une néarthrose inter-épineuse* ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ;
  - siège au niveau d'un **pédicule** ⇒ image suspecte de lésion osseuse secondaire.

3. Coxarthrose

- Diagnostic prêtant à confusion si l'arthrose n'est pas éloquente radiologiquement, surtout dans les formes agressives polaires supérieures.
- Diagnostic différentiel : ostéonécrose → incidence de profil ou TEMP.

4. Gonarthrose

- Hyperfixation modérée, répartie de façon hétérogène, ou hyperfixation plus intense prédominant sur un compartiment.
- L'atteinte simultanée du condyle + plateau tibial ⇒ arthrose.

5. Autres localisations

Rhizarthrose, interphalangiennes, acromio-claviculaire, sterno-claviculaire, omo-humérale.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment évolue la fixation des ostéophytes ?	Très intense lors de leur constitution, puis isofixants à long terme.
2. Aspect de l'arthrose cervicale ?	Hyperfixations latéralisées (uncarthrose).
3. En TEMP, quelle localisation vertébrale doit faire suspecter une métastase ?	Une hyperfixation siégeant au niveau d'un pédicule.
4. Diagnostic différentiel de la coxarthrose et moyen de le trancher ?	Ostéonécrose ; incidence de profil ou TEMP.
5. Quel aspect signe l'arthrose au genou ?	Atteinte simultanée du condyle et du plateau tibial.